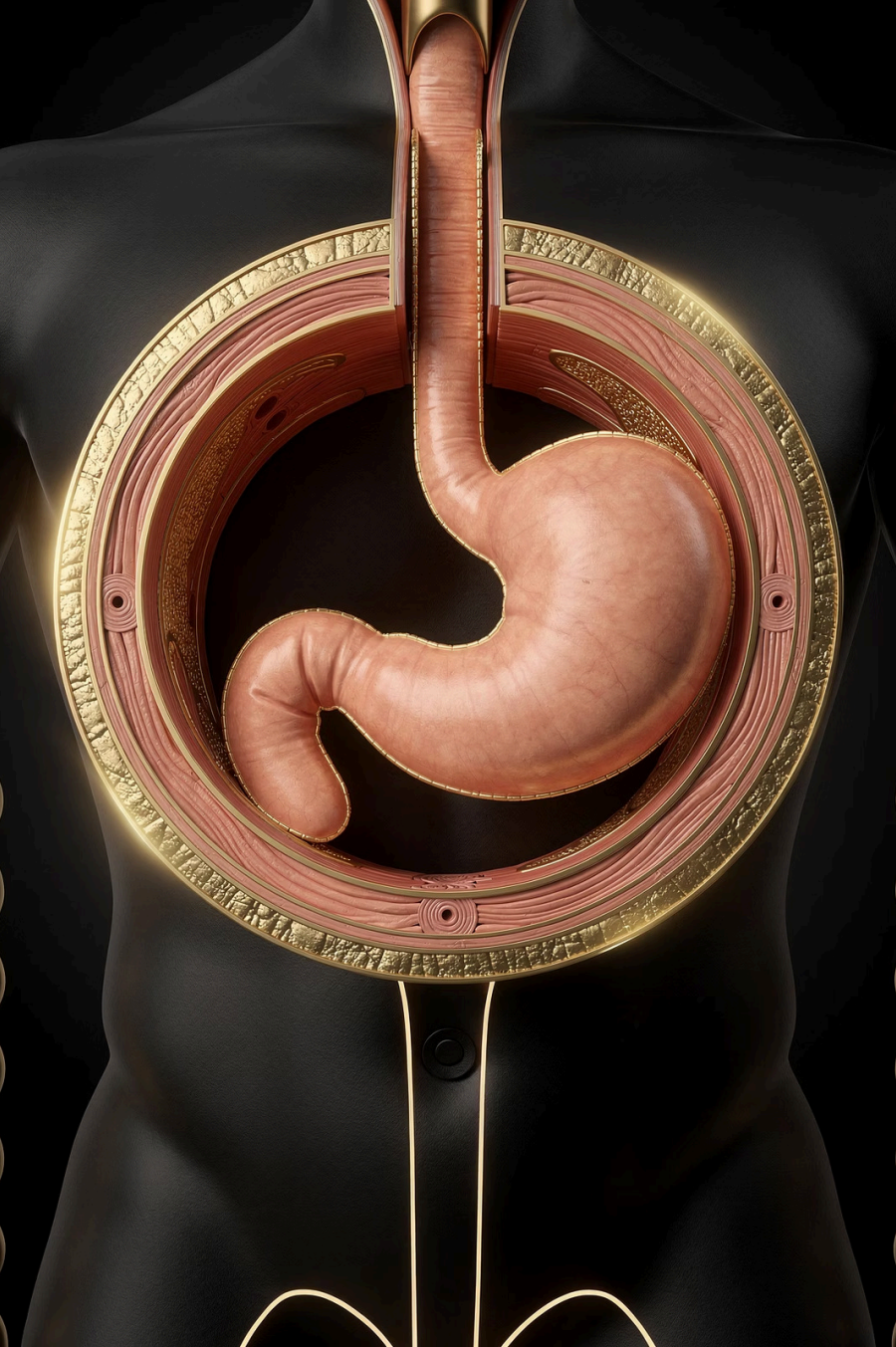




DRGE — Clínica e Diagnóstico

PARTE 3 · SLIDES 41-60

Esta seção aprofunda a interpretação clínica da Doença do Refluxo Gastroesofágico, abordando o espectro de apresentações, a diferenciação diagnóstica entre fenótipos, os erros mais comuns na prática e o arsenal de métodos diagnósticos disponíveis. O objetivo é capacitar o especialista a reconhecer, classificar e investigar a DRGE com precisão e critério clínico.

Apresentação Clínica — Visão Geral

A DRGE é uma das condições mais prevalentes na prática gastroenterológica e se destaca pela ampla variabilidade de sua expressão clínica. Longe de ser uma doença com apresentação uniforme, ela pode manifestar-se de formas distintas em diferentes pacientes — e, em alguns casos, de forma completamente silenciosa.

Sintomas Típicos

Pirose e regurgitação ácida. Constituem o núcleo diagnóstico clássico da doença e orientam o diagnóstico presuntivo inicial.

Sintomas Atípicos

Dor torácica, disfagia, náuseas e eructações. Podem mimetizar outras condições e dificultar o diagnóstico diferencial.

Manifestações Extraesofágicas

Tosse crônica, asma, laringite e rouquidão. Envolvem mecanismos indiretos como microaspiração e reflexo vagal.

📌 **Princípio fundamental:** A ausência de sintomas não exclui a doença, e a intensidade dos sintomas não define a gravidade das lesões. Um paciente assintomático pode ter esôfago de Barrett, enquanto um paciente com pirose intensa pode ter endoscopia normal.

Sintomas Típicos da DRGE

APRESENTAÇÃO CLÁSSICA

Pirose

Sensação de queimação retroesternal que ascende do epigástrio em direção ao pescoço. É o sintoma cardinal da DRGE e possui alto valor preditivo positivo quando presente de forma típica.

Regurgitação Ácida

Retorno espontâneo e passivo do conteúdo gástrico à orofaringe, com percepção de sabor azedo ou amargo. Frequentemente acompanha a pirose nos casos mais graves.

Padrão Temporal Característico

A apresentação clínica dos sintomas típicos segue um padrão bem definido que auxilia no reconhecimento diagnóstico:

- **Piora pós-prandial:** especialmente após refeições volumosas e ricas em gordura, o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior (EIE) favorece o refluxo
- **Piora ao deitar:** a posição supina elimina o efeito gravitacional de clareamento esofágico, prolongando o contato do ácido com a mucosa
- **Piora com manobras de Valsalva:** aumento da pressão abdominal agrava o refluxo
- **Melhora com antiácidos:** resposta rápida a neutralizantes sugere componente ácido predominante
- **Melhora na posição vertical:** a postura ereta favorece o clareamento esofágico por gravidade

Pirose — Detalhamento Clínico e Fisiopatológico

A pirose é o sintoma mais característico e clinicamente relevante da DRGE. Sua fisiopatologia envolve a exposição da mucosa esofágica ao conteúdo ácido gástrico, ativando quimiorreceptores e nociceptores na submucosa. Contudo, o limiar de percepção varia substancialmente entre indivíduos, o que explica a dissociação entre sintomas e lesão mucosa.

Desencadeantes Clássicos

- **Refeições volumosas:** distensão gástrica aumenta os episódios de relaxamento transitório do EIE
- **Gorduras e frituras:** retardam o esvaziamento gástrico e reduzem o tônus do EIE
- **Chocolate e café:** contêm metilxantinas que relaxam o EIE
- **Álcool e cítricos:** aumentam a acidez gástrica e comprometem a barreira mucosa
- **Tabagismo:** reduz a pressão de repouso do EIE e prejudica a salivação (clareamento esofágico)

Fisiopatologia da Percepção

A pirose resulta da ativação de receptores TRPV1 e ASIC na mucosa esofágica pelo pH ácido. O processamento central da dor visceral é modulado pelo sistema nervoso autônomo e por fatores psicológicos, o que explica por que:

- Pacientes ansiosos podem ter pirose intensa com exposição ácida mínima
- Pacientes com esofagite grave podem ser oligossintomáticos
- A resposta ao tratamento é variável e não proporcional à intensidade inicial

📌 **Conceito clínico essencial:** A pirose deve ser contextualizada em relação a frequência, duração, impacto na qualidade de vida e associação com outros sintomas — não apenas pela sua presença ou ausência.

Mecanismos da Pirose — Além do Ácido

FISIOPATOLOGIA AVANÇADA

Um dos equívocos mais comuns na prática clínica é associar pirose exclusivamente ao refluxo ácido. A literatura atual demonstra que a pirose pode ser gerada por diferentes mecanismos, cada um com implicações terapêuticas distintas. Compreender essa heterogeneidade é fundamental para evitar tratamentos inadequados.

Refluxo Ácido Clássico

pH < 4 no esôfago distal. É o mecanismo mais estudado e o principal alvo dos inibidores de bomba de prótons (IBP). Presente na maioria dos pacientes com esofagite erosiva.

Refluxo Fracamente Ácido

pH entre 4 e 7. Ocorre especialmente no período pós-prandial, quando o tamponamento pela refeição eleva o pH gástrico. Detectado apenas pela impedância-pHmetria. Importante em pacientes em uso de IBP que permanecem sintomáticos.

Refluxo Biliar (Alcalino)

Conteúdo duodenal (bile e suco pancreático) refluindo ao esôfago. pH > 7. Causa lesão mucosa independente do ácido. Mais frequente após gastrectomia. Pior resposta aos IBP.

Hipersensibilidade Esofágica

Exposição ácida dentro dos limites normais, mas com percepção exacerbada por sensibilização central ou periférica. Responde melhor a neuromoduladores (antidepressivos tricíclicos, duloxetina) do que a IBP.

📌 **Implicação prática:** Nem toda pirose é ácido-dependente. O médico deve suspeitar de mecanismos alternativos quando houver falha terapêutica com IBP em dose plena após 8 semanas.

Regurgitação — Definição e Significado Clínico

Definição Precisa

Regurgitação é o retorno **passivo e involuntário** do conteúdo gástrico ou esofágico para a faringe ou cavidade oral, sem contrações musculares propulsivas (ausência de náusea precedente ou esforço muscular abdominal). O paciente percebe o conteúdo na boca com sabor ácido ou amargo, muitas vezes sem desconforto prévio.

Diferenciação do Vômito

O vômito é um ato **ativo e reflexo**, precedido por náusea, hipersalivação, palidez e contração da musculatura abdominal e diafrágica. Esta distinção é clinicamente relevante para o diagnóstico diferencial com gastroparesia, obstrução de saída gástrica e distúrbios do controle central.

Significado Clínico na DRGE

A presença de regurgitação frequente sugere maior comprometimento da barreira antirrefluxo e correlaciona-se com:

- Incompetência mais grave do EIE
- Maior exposição ácida esofágica
- Maior risco de complicações (esofagite, Barrett)
- Possível hérnia hiatal associada
- Pior resposta ao tratamento clínico isolado

📌 **Atenção diagnóstica:** A regurgitação pós-prandial imediata e volumosa, associada à disfagia progressiva, deve levantar suspeita de divertículo de Zenker ou acalásia — não de DRGE simples.

Sintomas Atípicos da DRGE

Os sintomas atípicos representam um desafio diagnóstico relevante, pois podem ser a única manifestação da DRGE ou coexistir com os sintomas típicos. Sua presença isolada frequentemente leva a investigações demoradas em outras especialidades antes que a DRGE seja considerada como etiologia.



Dor Torácica Não Cardíaca

Corresponde a até 50% dos casos de dor torácica sem etiologia cardíaca identificada. Pode ser indistinguível da angina. Investigação cardiológica prévia é mandatória.



Odinofagia

Dor durante a deglutição. Menos comum que a disfagia, mas quando presente sugere esofagite grave ou úlcera esofágica. Requer endoscopia precoce.



Disfagia

Dificuldade de deglutição pode ocorrer por esofagite intensa, estenose péptica ou dismotilidade associada. Quando presente, é sinal de alarme que indica investigação endoscópica.



Náuseas e Eructações

Náuseas sem vômito e eructações frequentes podem refletir dismotilidade gastroesofágica associada. Também podem indicar síndrome de aerofagia ou ruminação — diagnósticos diferenciais importantes.

📌 **Armadilha diagnóstica:** Sintomas atípicos isolados têm baixa especificidade para DRGE. A ausência de pirose associada reduz consideravelmente a probabilidade diagnóstica e exige confirmação objetiva antes de iniciar tratamento prolongado com IBP.

Manifestações Extraesofágicas

REFLUXO ALÉM DO ESÔFAGO

Principais Manifestações

Tosse crônica: uma das causas mais frequentes. Deve ser investigada após excluir asma e gotejamento pós-nasal. O diagnóstico de DRGE como causa da tosse requer confirmação objetiva.

Asma de difícil controle: o refluxo pode desencadear broncoespasmo por microaspiração ou reflexo vagal broncoconstritor. Considerar DRGE em asmáticos com pior controle noturno.

Laringite posterior e rouquidão: eritema e edema das aritenoides são achados laringoscópicos sugestivos, embora inespecíficos.

Globus faríngeo: sensação persistente de "algo preso na garganta" sem disfagia objetiva. Associação com DRGE é controversa.

Mecanismos Fisiopatológicos

Dois mecanismos principais explicam as manifestações extraesofágicas:

- **Microaspiração:** pequenas partículas de conteúdo gástrico atingem a laringe, traqueia e brônquios, causando irritação direta da mucosa respiratória. Mais relevante na tosse e na asma.
- **Reflexo vagal esofagobrônquico:** a acidificação do esôfago distal ativa aferentes vagais que desencadeiam broncoespasmo reflexo, mesmo sem aspiração. Explica a tosse noturna em pacientes sem evidência de aspiração.

📌 **Conceito clínico:** As manifestações extraesofágicas raramente respondem a IBP de forma tão expressiva quanto os sintomas típicos. A resposta parcial é a regra, e outros diagnósticos devem ser sempre considerados em paralelo.

Refluxo Laringofaríngeo (RLF)

ATENÇÃO: CONTROVERSO

O refluxo laringofaríngeo é uma entidade diagnóstica que descreve o retorno do conteúdo gástrico até a hipofaringe e laringe, causando sintomas predominantemente respiratórios e otorrinolaringológicos. Embora amplamente diagnosticado na prática clínica, o RLF é cercado de controvérsias quanto a seus critérios diagnósticos e seu real impacto clínico.

Características Clínicas do RLF

- Rouquidão matinal e pigarro frequente
- Sensação de muco na garganta (gotejamento pós-nasal)
- Tosse crônica seca
- Globus faríngeo persistente
- **Pirose está ausente em até 40% dos casos**
- Sintomas frequentemente piores pela manhã (refluxo noturno)

Por que o RLF é frequentemente Superdiagnosticado?

O diagnóstico de RLF na prática otorrinolaringológica frequentemente baseia-se em achados laringoscópicos como eritema posterior e edema das aritenoides. Entretanto, estudos controlados demonstram que esses achados têm **baixa especificidade**, estando presentes em até 80% de voluntários saudáveis assintomáticos.

Além disso, os questionários clínicos utilizados (como o RSI — Reflux Symptom Index) não distinguem com confiabilidade RLF de outras condições como rinite alérgica, gotejamento pós-nasal e disfonia funcional.

❏ **Erro comum:** Iniciar IBP em dose dupla por 3–6 meses com base apenas em sintomas laringeos sem phmetria prévia é uma prática de baixa eficácia e expõe o paciente a riscos desnecessários.

Superdiagnóstico e Erros Comuns na DRGE

⚠ ARMADILHAS CLÍNICAS

O superdiagnóstico da DRGE é um problema clínico relevante e subestimado. A combinação de sintomas inespecíficos com a disponibilidade de tratamento empírico com IBP leva frequentemente ao diagnóstico presuntivo incorreto, expondo pacientes a tratamentos desnecessários e atrasando o diagnóstico correto.

1

Tratar Sintomas Atípicos Sem Confirmação

Tosse crônica, laringite e asma têm múltiplas etiologias. Iniciar IBP sem phmetria em pacientes sem pirose associada resulta em taxas de resposta próximas ao placebo (30–40%).

2

Interpretar Resposta ao IBP como Confirmação Diagnóstica

O teste terapêutico com IBP tem especificidade limitada (~50%). O efeito placebo em estudos controlados alcança 30% de melhora — o que significa que a melhora sintomática não confirma DRGE.

3

Não Investigar Diagnósticos Alternativos

Pirose funcional, hipersensibilidade esofágica, acalásia, esofagite eosinofílica e dispepsia funcional podem mimetizar DRGE. Sem confirmação objetiva, o tratamento será ineficaz.

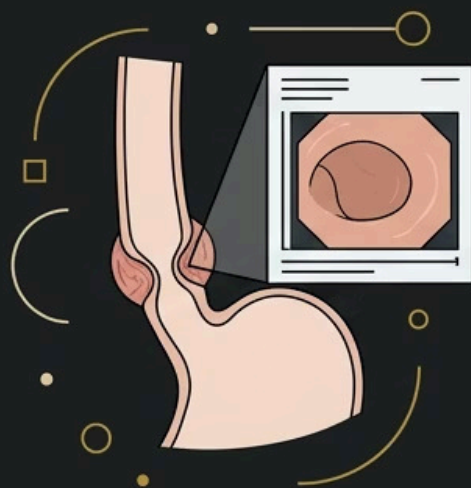
4

Manter IBP Indefinidamente Sem Reavaliação

O uso crônico de IBP sem indicação confirmada expõe o paciente a riscos como deficiência de magnésio, vitamina B12, osteoporose e infecção por *Clostridioides difficile*.

Fenótipos da DRGE — Classificação Atual

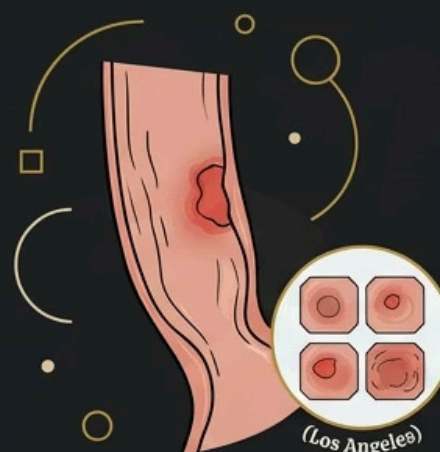
A compreensão moderna da DRGE supera a visão dicotômica "com ou sem lesão mucosa". A classificação por fenótipos, incorporada ao Consenso de Lyon 2.0 (2024), tem implicações diretas no diagnóstico, prognóstico e estratégia terapêutica de cada paciente.



1) DRGE Não Erosiva (NERD)

Sintomas típicos,
EDA normal.

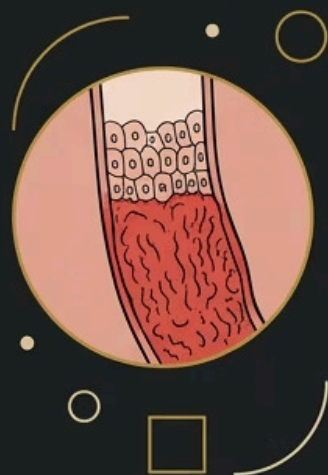
60% dos casos.



2) Esofagite Erosiva

Lesão mucosa visível
à endoscopia.

Graus A-D Los Angeles.



3) Esôfago de Barrett

Metaplasia
intestinal,
Risco de
adenocarcinoma.



4) Hipersensibilidade ao Refluxo

Exposição ácida
normal.
Percepção aumentada.
Mal-resposta a IBP.



5) Pirose Funcional

Sem relação
com refluxo.
Distúrbio funcional
Roma IV.

Esta classificação fenotípica tem importância prática fundamental: o tratamento e o prognóstico diferem substancialmente entre os fenótipos. Pacientes com pirose funcional ou hipersensibilidade esofágica frequentemente não se beneficiam de IBP e necessitam de abordagem direcionada aos mecanismos de hipersensibilidade visceral e fatores psicológicos.

DRGE Não Erosiva (NERD)

FENÓTIPO MAIS PREVALENTE

Definição e Prevalência

A DRGE Não Erosiva (NERD — Non-Erosive Reflux Disease) é definida pela presença de sintomas típicos de DRGE com endoscopia digestiva alta **normal** (ausência de erosões, úlceras ou metaplasia). Representa aproximadamente **60% de todos os casos** de DRGE, sendo o fenótipo mais comum na prática clínica.

Por que a endoscopia é normal?

Na NERD, pode haver exposição ácida anormal documentada à phmetria, mas sem lesão mucosa endoscopicamente visível — o que sugere que a resistência epitelial individual é um fator determinante no desenvolvimento ou não de erosões.

Características Clínicas e Associações

- Sintomas típicos de pirose e regurgitação com mesma intensidade que a DRGE erosiva
- Maior prevalência em mulheres e pacientes mais jovens
- Frequente associação com **síndrome do intestino irritável** e **dispepsia funcional**
- Maior prevalência de distúrbios de ansiedade e depressão
- Resposta ao IBP geralmente inferior à da esofagite erosiva (70–80% vs. 85–90%)

Subgrupos dentro da NERD

Estudos com phmetria e impedância demonstram que a NERD é heterogênea e inclui pacientes com exposição ácida patológica, hipersensibilidade ao refluxo e pirose funcional — o que explica a variabilidade na resposta terapêutica e reforça a necessidade de investigação complementar em casos refratários.

Hipersensibilidade Esofágica

A hipersensibilidade esofágica representa um fenótipo clinicamente desafiador em que o paciente apresenta **sintomas típicos de DRGE**, porém com **exposição ácida dentro dos limites normais** à phmetria. A correlação entre os eventos de refluxo documentados e os sintomas é positiva (índice de sintomas elevado), o que distingue esta condição da pirose funcional.

Mecanismo Fisiopatológico

O mecanismo central é a **sensibilização visceral** — tanto periférica quanto central:

- **Periférica:** aumento da expressão de receptores TRPV1 na mucosa esofágica, com menor limiar de ativação por estímulos ácidos ou mecânicos
- **Central:** amplificação do processamento da dor no sistema nervoso central (hiperalgesia visceral central), mediada por alterações nos sistemas serotoninérgico e opioide
- **Mediadores inflamatórios:** citocinas como IL-8 e TNF- α podem sensibilizar aferentes vagais mesmo na ausência de lesão macroscópica

Implicações Terapêuticas

❏ **Não responde bem a IBP!** Esta é a diferença prática mais importante. O aumento da dose de IBP em pacientes com hipersensibilidade esofágica raramente produz benefício adicional.

Abordagens terapêuticas com maior evidência:

- **Neuromoduladores:** antidepressivos tricíclicos (amitriptilina 10–25 mg/noite), duloxetina ou citalopram reduzem a hipersensibilidade visceral
- **Terapia cognitivo-comportamental:** benefício demonstrado em estudos controlados
- **Hipnoterapia dirigida ao intestino:** evidência crescente para hipersensibilidade visceral

Pirose Funcional

DISTÚRBIO FUNCIONAL — ROMA IV

A pirose funcional é classificada pelos **Critérios de Roma IV** como um distúrbio da interação intestino-cérebro. Difere da hipersensibilidade esofágica pelo fato de que, além da exposição ácida normal, a correlação entre os eventos de refluxo e os sintomas é **negativa** — ou seja, os sintomas não ocorrem no momento dos episódios de refluxo documentados.

Critérios Roma IV para Pirose Funcional Sintomas retrosternais de queimação por pelo menos 3 dias por semana nos últimos 3 meses, com ausência de correlação com refluxo gastroesofágico (exposição ácida normal E índice de sintomas negativo), ausência de distúrbio motor maior e ausência de lesão mucosa.	Por que os Exames São Normais? Na pirose funcional, a fisiopatologia envolve alterações no processamento central da dor visceral sem substrato orgânico demonstrável. O esôfago está anatômica e fisiologicamente normal. A phmetria confirma exposição ácida normal e ausência de correlação sintomática.	Abordagem Terapêutica IBP têm eficácia semelhante ao placebo. O tratamento de primeira linha inclui: explicação adequada ao paciente, neuromoduladores em baixa dose, psicoterapia e abordagem dos fatores psicossociais desencadeantes. Evitar escalonamento terapêutico desnecessário.
--	--	--

Diagnóstico Clínico da DRGE

Bases do Diagnóstico Clínico

Em pacientes com apresentação clínica típica — pirose e/ou regurgitação ocorrendo pelo menos 2 vezes por semana, com padrão pós-prandial e melhora com antiácidos — o diagnóstico clínico presuntivo de DRGE é razoável e justifica o início de tratamento empírico. Esta abordagem é especialmente válida em pacientes jovens, sem sinais de alarme e com apresentação inicial da doença.

Crítérios para Diagnóstico Clínico

- Pirose típica com frequência ≥ 2 episódios/semana
- Padrão pós-prandial e/ou noturno característico
- Resposta a antiácidos de ação rápida
- Ausência de sinais de alarme
- Idade inferior a 40–45 anos (varia conforme guideline)

Limitações do Diagnóstico Apenas Clínico

Baixa Especificidade

Pirose pode ocorrer em dispepsia funcional, esofagite eosinofílica, acalásia e úlcera péptica. A apresentação clínica típica não distingue estes diagnósticos com confiabilidade.

Variabilidade Individual

A percepção dos sintomas é influenciada por fatores psicológicos, cognitivos e culturais. Isso compromete a utilização do diagnóstico clínico como referência para monitoramento da resposta terapêutica.

Risco de Subdiagnóstico

Pacientes com DRGE assintomática (esôfago de Barrett sem pirose) não serão identificados pelo diagnóstico clínico, o que reforça a necessidade de rastreamento endoscópico em grupos de risco.

Teste Terapêutico com IBP

DIAGNÓSTICO EMPÍRICO

O teste terapêutico com IBP consiste na administração de um IBP em dose padrão ou dobrada por 4–8 semanas, considerando-se o resultado positivo quando há melhora sintomática significativa. É amplamente utilizado como primeira abordagem diagnóstica e terapêutica simultânea em pacientes com apresentação típica e sem sinais de alarme.

Como Realizar o Teste

- IBP em dose padrão (ex: omeprazol 20 mg ou pantoprazol 40 mg) **30 min antes do café da manhã** por 4–8 semanas
- Para sintomas atípicos: dose dobrada, duas vezes ao dia, por 8 semanas
- Critério de positividade: redução $\geq 50\%$ dos sintomas
- Reavaliação ao fim do período com decisão sobre manutenção ou investigação

Limitações Críticas do Teste

O teste terapêutico com IBP **não confirma o diagnóstico de DRGE** e deve ser interpretado com cautela:

- **Especificidade limitada (~50%):** IBP podem melhorar sintomas de dispepsia funcional, úlcera péptica e esofagite eosinofílica
- **Efeito placebo significativo:** até 30% de resposta em estudos controlados com placebo — a melhora sintomática, portanto, não é prova de DRGE
- **Falso negativo em NERD:** pacientes com hipersensibilidade ou pirose funcional podem não responder mesmo que DRGE esteja presente
- **Mascaramento de diagnósticos alternativos:** retarda a investigação de condições como esofagite eosinofílica ou adenocarcinoma inicial

Indicações de Endoscopia Digestiva Alta (EDA)

A endoscopia digestiva alta não é necessária para o diagnóstico inicial de DRGE em pacientes jovens com apresentação típica e sem sinais de alarme. No entanto, existem situações bem definidas em que sua realização é mandatória, seja para estratificação de risco, confirmação diagnóstica ou exclusão de condições graves.



Sinais de Alarme

Disfagia progressiva, odinofagia, hematêmese, melena, perda de peso involuntária (>5% em 6 meses) e anemia ferropriva. Qualquer sinal de alarme indica EDA urgente ou precoce, independentemente da idade.



Idade Avançada + Sintomas Crônicos

Pacientes acima de 40–45 anos com sintomas há mais de 5 anos, especialmente do sexo masculino, obesos ou tabagistas, têm maior risco de esôfago de Barrett e devem ser rastreados endoscopicamente.



Refratariedade ao Tratamento

Ausência de resposta após 8 semanas de IBP em dose adequada. A endoscopia permite identificar esofagite persistente, estenose, Barrett não diagnosticado ou diagnóstico alternativo.



Planejamento Cirúrgico

Antes de qualquer procedimento antirrefluxo (fundoplicatura), a EDA é obrigatória para avaliar o grau de esofagite, presença de hérnia hiatal, Barrett e excluir outras patologias.

Papel da Endoscopia no Diagnóstico da DRGE

O que a EDA Permite Avaliar

- **Identificar esofagite erosiva:** classificada pela escala de Los Angeles (graus A a D), com implicações prognósticas e terapêuticas diretas
- **Detectar esôfago de Barrett:** identificar e biopsiar segmentos de metaplasia intestinal para estratificação do risco de adenocarcinoma
- **Avaliar complicações:** estenose péptica, úlcera esofágica, sangramento
- **Excluir diagnósticos alternativos:** esofagite eosinofílica (requer biópsia), acalásia, tumores
- **Avaliar hérnia hiatal:** tipo, tamanho e impacto funcional

Limitações da Endoscopia

- ❏ **Atenção:** A EDA pode ser completamente normal em até 60–70% dos pacientes com DRGE sintomática, especialmente nos fenótipos NERD, hipersensibilidade e pirose funcional. Uma endoscopia normal, portanto, não exclui DRGE.

A endoscopia avalia apenas alterações **macroscópicas** da mucosa. Não documenta exposição ácida, não avalia função do EIE, não detecta refluxo não ácido e não fornece informações sobre motilidade esofágica. Para estes objetivos, são necessários exames funcionais complementares.

Classificação de Los Angeles

- **Grau A:** erosões ≤ 5 mm, não confluentes
- **Grau B:** erosões > 5 mm, não confluentes
- **Grau C:** erosões confluentes $< 75\%$ da circunferência
- **Grau D:** erosões confluentes $\geq 75\%$ da circunferência

pHmetria e Impedância-pHmetria

PADRÃO-OURO DIAGNÓSTICO

A pHmetria esofágica ambulatorial de 24 horas é considerada o **padrão-ouro** para a documentação objetiva da exposição ácida esofágica. Com o advento da impedância-pHmetria multicanal, tornou-se possível detectar refluxos independentemente de seu pH, incluindo os eventos fracamente ácidos e alcalinos.

pHmetria Convencional

O que mede: exposição ácida esofágica (tempo com $\text{pH} < 4$). O principal parâmetro é a **fração de tempo com $\text{pH} < 4$** (normal: $< 4\%$ em posição ortostática, $< 6\%$ supina). Outros parâmetros incluem número de episódios e índice de sintomas (IS).

Indicações: diagnóstico duvidoso, sintomas persistentes com EDA normal, pré-operatório de fundoplicatura, avaliação pós-operatória.

Impedância-pHmetria Multicanal (MII-pH)

Vantagem diferencial: detecta **todos os tipos de refluxo** — ácido, fracamente ácido e alcalino — além de diferenciar refluxo líquido, gasoso e misto. Fundamental em pacientes refratários ao IBP, pois permite identificar se os sintomas persistentes decorrem de refluxo não ácido (sem indicação de escalada do IBP) ou de hipersensibilidade.

Métricas adicionais: clearance esofágico, índice de sintomas associado à impedância (ISAI) e número de refluxos proximais.

Interpretação Integrada

O **Consenso de Lyon 2.0 (2024)** estabelece parâmetros diagnósticos baseados em evidências: exposição ácida $> 6\%$ confirma DRGE; entre $4\text{--}6\%$ é zona cinzenta; $< 4\%$ torna DRGE improvável. O número total de refluxos $> 80/24\text{h}$ é evidência de suporte adicional. A correlação sintomática (índice de sintomas $\geq 50\%$) é relevante quando a exposição ácida está na zona cinzenta.

Manometria Esofágica — Função no Diagnóstico da DRGE

A manometria esofágica de alta resolução (MAR) avalia a função motora do esôfago e dos esfíncteres gastroesofágico (EIE) e faringoesofágico (EES). Embora não diagnostique DRGE diretamente, é um exame indispensável na investigação completa do paciente com refluxo, especialmente no contexto pré-operatório.

O que a Manometria Avalia

- **Pressão de repouso do EIE:** valores reduzidos (< 10 mmHg) sugerem incompetência esfíncteriana
- **Relaxamento do EIE durante a deglutição:** relaxamento incompleto sugere acalásia — diagnóstico diferencial crítico
- **Peristalse esofágica:** avaliação de motilidade ineficaz (reduz o clearance esofágico)
- **Pressão de repouso do EES:** relevante nas manifestações extraesofágicas

Indicações Principais na DRGE

01

Pré-operatório obrigatório: antes de qualquer cirurgia antirrefluxo, para avaliar peristalse (funduplicatura total vs. parcial) e excluir acalásia

02

Posicionamento da sonda de phmetria: a phmetria requer posicionamento correto do cateter a 5 cm acima do EIE — o que só pode ser feito com a manometria prévia

03

Sintomas persistentes atípicos: disfagia, regurgitação volumosa ou dor torácica sem esofagite sugerem distúrbio motor primário

04

Avaliação pós-operatória: investigação de disfagia e recidiva sintomática após funduplicatura

❏ **Conceito essencial:** A manometria é o exame que *posiciona* o diagnóstico — ela contextualiza o ambiente motor em que o refluxo ocorre, sem diagnosticá-lo diretamente.